

양방진단학 SUMMARY 공지사항

- 써머리 전체가 시험범위이니 잘 읽어보세요.

양방진단학 SUMMARY 사용법

- 중요해 보이는 내용은 가독성을 위해 **굵은 글씨**와 **빨간 글씨**, **파란 글씨**로 표시하겠습니다.

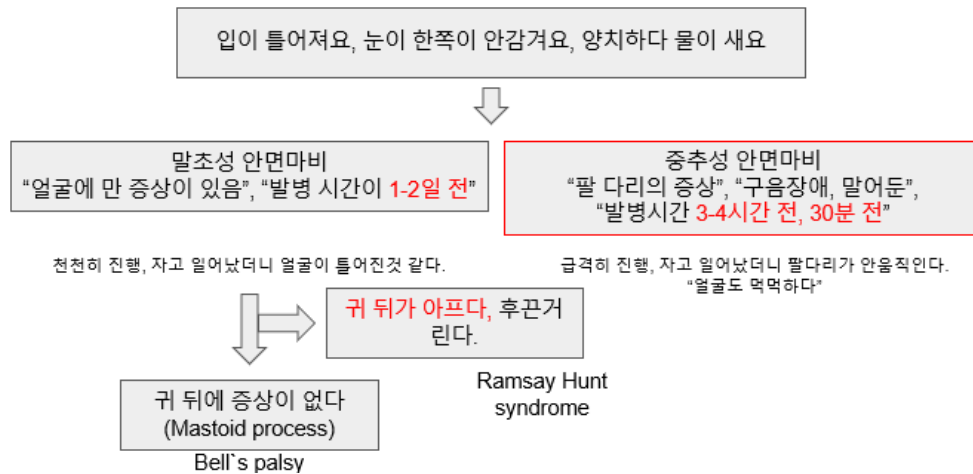
안면마비의 접근법과 치료

- 안면마비 (구안와사) 공부를 해야하는 이유

1) 한의수요가 높은 질환. 2) 한의치료가 우수한 질환. 3) 청약건강보험 해당 질환
- 구안와사는 한방에서 한의 수요가 높은 질환이고 한의치료가 우수하며, 청약 건강 보험에 해당하는 질환이다.

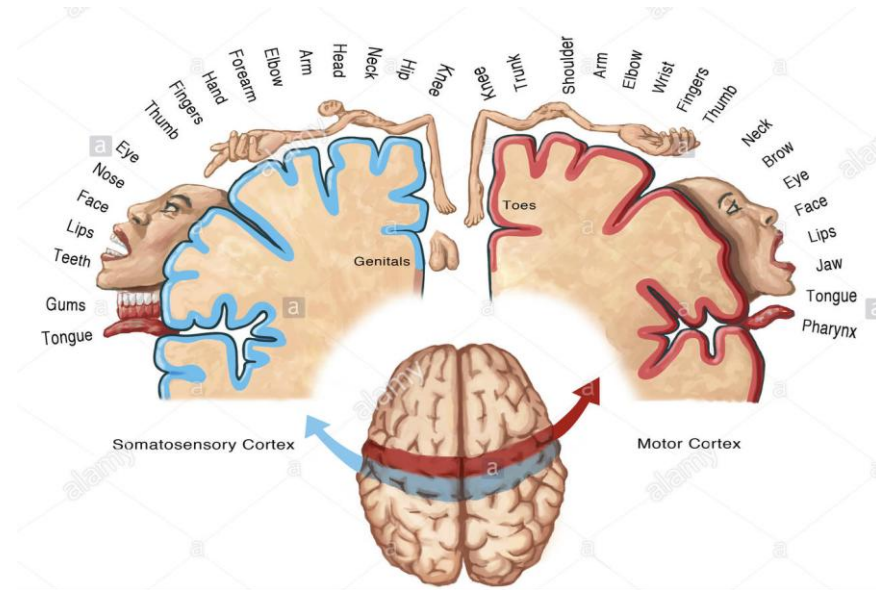
- 협진을 진행하면 수가를 더 주는 시범사업이 있고, 이는 치료기간도 단축시키고 만족도도 높다고 한다.

1. 감별: 구안와사와 구안와사가 아닌 질환



- 보통은 이마 주름으로 감별한다고 하는데 실제 임상에서는 이마 주름이 잘 안만들어지는 경우도 있기에 확실하게 감별하기 어렵다.

- 제일 중요한 것은 증상이 언제부터 생겼는지이다. 말초성의 경우는 1-2 일 전에 발생하고, 중추성의 경우 3-4 시간 전, 30 분 전에 주로 발생한다.
- 구음장애는 말이 잘 안나오는 것이고 중추성 안면마비의 감별점이다.
- 아래 지도 그림을 보면 혀나 얼굴쪽이 붙어있기 때문에 중추성 안면마비는 구음장애가 동반될 수 있다.(말초성 안면마비는 얼굴에만 증상이 있음)
- 말초성 안면마비는 천천히 진행되어 자고 일어났더니 얼굴이 틀어진 것 같다고 표현하고, 중추성 안면마비는 급격히 진행되어 자고 일어났더니 팔다리가 안움직인다, 얼굴도 먹먹하다고 표현한다.
- 한의원에서 중추성과 말초성을 구분하는 것은 중풍을 감별해내는 것과 같기에 매우 중요하다.



1. 실제 1 차 의료기관에서 감별 진단 사례: 중풍/ 와사

<중추성 안면마비>

- 1) 증상이 병원에 오는 도중에도 진행되는 점이 있었다.
 - 2) 아침에 일어나서 증상을 발견했지만, 현재(오후 시간) **증상에 차이가 있다.**
 - 3) **손 발에 힘이 없다** (특히 편측) / 손 발에 감각이 이상하다 (Pons, Thalamic infarction)
 - 4) "구음장애", "말이 둔하다", "단어가 기억이 잘 안난다"
- > Motor control 을 하는 Nerve tract 이 대뇌의 Basal ganglia, Pons, Thalamus 등을 지나가기 때문에 손과 발의 증상이 함께 나타나는 것.

<말초성 안면마비>

- 1) 주로 **얼굴 증상에 대한 설명.**
- 2) 눈 : 눈이 안감긴다(세수할 때 눈에 물이 들어가서 따갑다)
- 3) 구강내 : 식사시에 밥이 한쪽 이빨에 자주 낀다, 고인다, 밥이 찬다.
- 4) 입 : 양치할때 물이 한쪽으로 흐른다, 휘파람 불기가 힘들다, 물을 마시면 물이 샌다.

- 교수님은 말이 어눌하지 않은지, 손발의 증상이 동반되는지를 중요한 포인트로 보고 감별한다.

2. 진단: 구안와사입니다. 안면마비입니다.

- 전체적으로 마비측은 근육의 Tension 유지가 안되어 **주름이 건축에 비해 퍼진 상태임.**
- **충혈** : 흔히 놓치는 부분으로 눈이 완벽하게 폐안이 되지 않다보니 충혈, 결막염 흔히 발생
- > 초기부터 관리해야함
- > 너무 심한경우 테이프등을 붙여서 폐안시킴. (인공눈물 꼭 티칭할것)
- 안면신경의 3 개 가지에 따라 증상에 차이가 있을 수 있으나, 대부분 편측 안면에 **전반적으로 증상이 나타나게 된다.**
- 전체적으로 **편측 안면은 부종** 증상이 나타나기도 한다. (근육 움직임이 일어나지 않아 정맥계, 림프계 울혈 등)



발병 후 5일, 점진적 진행

- 안면마비는 보통 치료 안해도 해결된다고들 하는데, 실제로 그렇지 않고 더 심해질 수도 있기에 모니터링하는 것이 중요하다. 환자가 무대에 서는 직업을 가질 수도 있기 때문에 지금 치료 받지 않으면 심해질 수 있다는 것을 꼭 알려주고 치료해주는 것이 중요하다.
- 얼굴에 전기자극을 계속 주면 얼굴의 근육들이 한번에 수축하기 때문에 자연스럽지 않은 움직임이 발생한다. 이로 인해 전기침을 별로 추천하지 않는다.(교수님 한의원 환자는 주말에 다른 한의원에 내원하는 경우도 있는데, 이때 전기침을 맞는다고 하면 그냥 그러라고 하신다)

2.1 진단: 람세이헌트 증후군(매우 중요)

<Ramsay Hunt` syndrome> G510 안면마비

- 1) 이후통이 가장 감별진단에 중요(Mastoidal pain 이라고 함) /
- 2) 실제로 귀 뒤가 후끈거림 (심한 경우 잠을 잘 수 없을 정도)
- 3) 이런 환자들을 오래 방치하면 안면마비가 장기화 되는 경우도 있음.
(반드시 치료 필요)
- 4) 대상포진 바이러스(Herpes zoster)가 안면신경에 침입한 것. 이후부 혹은 이개부(귀)의 vesicle(수포) 혹은 기왕력 확인해보는 것이 도움.
- 5) 람세이헌트증후군의 경우 회복률이 20%정도에 그치는 것으로 알려져있음.

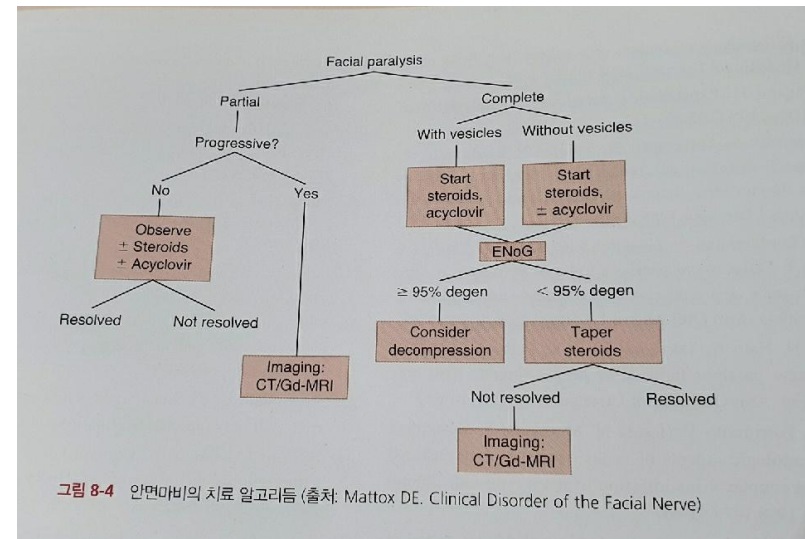
<Bell`s palsy>

- 1) 주로 마비증상에 대한 호소 (같은 마비라도 람세이헌트는 통증을 꼭 호소)
- 2) 자연 회복률이 70-80%에 달한다고 하나, 치료는 반드시 필요함

3. 양방치료 루틴-Medication

크게 스테로이드 / 항바이러스제 / 스테로이드+항바이러스제 요법으로 나뉨

- 1) 스테로이드 : 안면신경의 염증 해소, 안면신경의 (염증)부종 감소
 - 72 시간 이내에 시행해야 효과
 - 프레드니솔론 감량요법 (60mg 5일간, 이후 감량시작하여 총 10일간)
- 2) 항바이러스제 : 아시클로버, 발시클로버
 - 안면신경 내 바이러스 활성화가 병리기전으로 추정되고 있기 때문
 - 단독투여에서는 효과 없는 것으로 나옴 (코크란리뷰)
 - 주로 스테로이드 초기 고용량투여+항바이러스제 요법이 활용
 - 연구 자체에서 회복률의 차이는 관찰되지 않았음.(근거부족)
 - 로컬에서 루틴하게 쓰는 병행요법임.



- 환자가 바로 한의원으로 온 경우 스테로이드를 의뢰하는게 나은가? YES (책임분담)
- 3일 지나서 온 환자에게는 다름. 대부분 양방치료를 병행하고 있고, 양방치료가 아주 간단해서 양방치료를 알아야 함

3. 의과치료 루틴-SSP 등의 전기자극치료

- 코크란리뷰에서 물리치료는 회복률에 큰 이득이 없는 것으로 나오고 있으나, 근육의 재교육 및 근육 움직임을 통한 근위축 방지 등 다양한 효과가 있을 것으로 판단됨.
- 한의원에서도 은침자극요법, 경혈자극요법으로 SSP를 청구 가능함. (비급여)
- 약물 복용과 물리치료 외에 사실상 일차 의료기관에서 양방치료를 해줄 것이 없기 때문에 한의원으로 오게 됨.



4. 치료 설득-한의치료는 왜 받아야 하는가?

흔히 하는 오해

벨마비는 2-3개월 지나면 자연회복된다?

- 1) No! 초기에 치료를 받아야 후유증이 덜남는다.
- 2) Bell 마비의 자연회복은 미신임.
- 3) 신경염증으로 유발된 근육마비는 치료없이 절대 이전상태로 돌아갈 수 없음.

놓치고 있는 점

“마비는 진행된다. 언제까지? 신경회복이 일어날때까지”

- 1) 초기 7-14일 염증이 해소될때까지 마비는 진행
- 2) 마비=근육이 움직이지 않는것 -> 근위축, 부종
- 3) 치료를 받아도 마비는 진행된다, 다만 속도를 늦춤

<두가지 설명 멘트>(이야 이런거까지)

마비가 진행되는 기간 : 한방치료는 마비 진행의 브레이크다

마비가 회복되는 기간 : 한방치료는 마비 회복의 엑셀레이터다.

침치료는 브레이크와 엑셀 역할을 모두 한다. 왜? 신경자극이니까.

한약치료는 왜 해야될까? : 염증제거(초기) 신경회복(후기)

-> 때문에 저는 회복기에 약을 한번 바꿉니다. (實->虛)

에베레스트 올라갔다올걸, 무등산으로 바꿔줍니다.

빠르고, 덜힘들고, 심지어 싸요.

- 마비는 처음에 발생하면 1주일 동안은 진행되기에 우리가 하는 치료는 브레이크를 밟는 치료이고, 이후에 좋아질 것이라고 설명하면 된다.



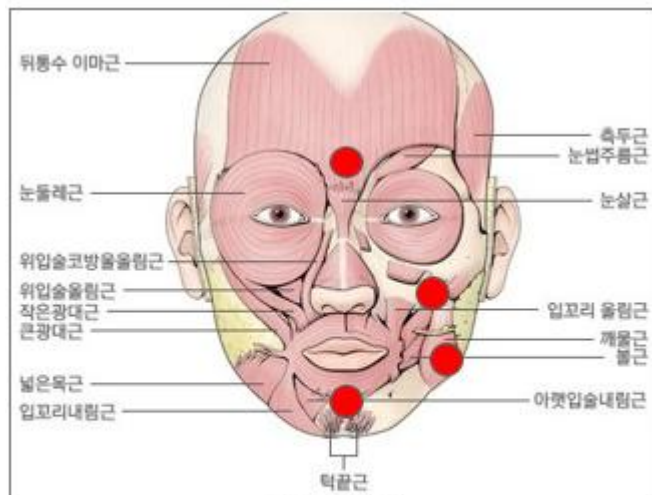
4. 치료 설득 - 건측에도 왜 침치료를 받나요?

원전

- 1) 한의 원전에서는 안면마비에 건측 치료를 추천함
- 2) 건측의 기운을 돌려서 환측에 심는 원리 정도로 과거에는 생각
- 3) 현재는 고유수용성 감각 촉진 등으로 해석하고 있음. (추나에서 설명)
- 4) 현대중의학에서도 환측 전침은 마른나무에 불을 지피는 형상이라고 설명하여 추천되지 않음 (논문상에서는 추천)

환자 설명 루틴

- 과사용으로 인한 안면근육 피로, 통증 방지
 - 1) 마비측 근육을 쓸 수 없다보니, 건측 근육(하악 등)을 과사용 하게 됩니다.
 - 2) 안면근육은 작고 얇은 근육들로 이루어져 있어 과사용시 빨리 피로해지고 통증 유발이 쉽습니다.
 - 3) 때문에 건측을 병행치료 해야합니다.



건측 루틴

- 1) 공동신경지배 근육 (임독맥경)
- 2) 대근육

5. 증상 관찰-평가척도

1) H-B Scale (House-Brackmann)

- 가장 심플해서 많이 씀. (Golden standard)
- G1은 정상 / G6은 완전마비
- G5는 외형적으로 입꼬리가 내려가있는게 관찰되고, 이마 움직임이 자발적으로 안되는 것. 밖에서 보기에 Resting 상태에서도 마비 명확
- G4는 아주 노력하면 눈이 거의 감길까말까한 정도. 움직임에서 마비가 확연히 드러남
- G3는 외형으로는 크게 차이 없으나 움직임에서 약간 이상이 관찰되고 위축 위약 등은 없는 상태
- G2는 마비가 아주 미약한 상태로 Resting 상태에서도 마비가 거의 드러나지 않고, 눈 감기 등도 최소한의 노력으로 가능
- 내원하는 환자는 G4-5에서 오고 G3-2 정도를 목표로 함.

Table 2. House-Brackmann Facial Nerve Grading System

Grade	Defined by
1 Normal	Normal facial function in all areas.
2 Mild dysfunction	Slight weakness noticeable only on close inspection. At rest: normal symmetry of forehead, ability to close eye with minimal effort and slight asymmetry. No synkinesis, contracture, or hemifacial spasm
3 Moderate dysfunction	Obvious, but not disfiguring difference between 2 sides, no functional impairment; noticeable but not severe synkinesis, contracture, and/or hemifacial spasm. At rest: normal symmetry and tone. Motion: slight to no movement of forehead, ability to close eye with maximal effort and obvious asymmetry, ability to move corners of mouth with maximal effort and obvious asymmetry. Patients who have obvious but no disfiguring synkinesis, contracture, and/or hemifacial spasm are grade III regardless of degree of motor activity.
4 Moderately severe dysfunction	Obvious weakness and/or disfiguring asymmetry. At rest: normal symmetry and tone. Motion: no movement of forehead; inability to close eye completely with maximal effort. Patients with synkinesis, mass action, and/or hemifacial spasm severe enough to interfere with function are grade IV regardless of motor activity
5 Severe dysfunction	Only barely perceptible motion. At rest: possible asymmetry with droop of corner of mouth and decreased or absence of nasal labial fold. Motion: no movement of forehead, incomplete closure of corner of mouth. Synkinesis, contracture, and hemifacial spasm usually absent.
6 Total paralysis	Loss of tone; asymmetry; no motion; no synkinesis, contracture, or hemifacial spasm.

2) Yanagihara's scale

HB scale 이 너무 심플하다보니 개별근육에 대한 상태 측정은 어려워 다양한 평가척도들이 나옴.

기능평가상에서 Yanagihara 쓰기도 하는데 총점 내는것이 번거로워서
일차의료기관에서는 잘 모르겠음
(차트 시스템에 내재되면 좋을듯)

Table 3. Yanagihara's Unweighted Grading System

		Scale of five rating					Scale of three rating		
At rest	0	1	2	3	4	0	2	4	
Wrinkle forehead	0	1	2	3	4	0	2	4	
Blink	0	1	2	3	4	0	2	4	
Closure of eye lightly	0	1	2	3	4	0	2	4	
Closure of eye tightly	0	1	2	3	4	0	2	4	
Closure of eye on involved side only	0	1	2	3	4	0	2	4	
Wrinkle nose	0	1	2	3	4	0	2	4	
Whistle	0	1	2	3	4	0	2	4	
Grin	0	1	2	3	4	0	2	4	
Depress lower lip	0	1	2	3	4	0	2	4	

5. 증상 관찰-마비단계에 따른 증상(자세하게 안하심)

- 슬상신경절 위쪽 신경의 마비인 경우 미각, 청각(난청), 타액분비까지 같이 오므로 해당 증상들을 함께 체크해봐야함

장해부위	안면마비	미각소실	청각과민	누선분비장애	타액분비장애	예후
고삭신경분지 이하	+	-	-	-	-	-
등자신경분지- 고삭신경분지 사이	+	+	-	-	+	-
슬상신경절- 등자근신경분지 이하	+	+	+	-	+	-
내이도-슬상신경절	+	+	+	+	+	완전마비 1
후두개와내	+	+	+	+	+	외전마비 1

5. 치료-침 치료

반드시 후경부 근육을 풀어줘야 함.

-> 매우 중요하다

-> 아예 옆으로 누워서 환측 얼굴과 이후부, 후경근 같이 치료하기도 함.

-> 귀뒤에서 신경이 나오기 때문에, 안면마비 증상이 오기전 환자는 반드시 뒷목이 뻣뻣한 증상이 온다.

-> 신경마비 증상으로 이어짐/ 후경부 근육을 잘 풀어줘야 한다.

•손상된 부위를 확인하여 해당 근육의 부착부에 자침.

•손상된 부위를 지배하는 신경의 경로와 출구를 자침.

•경결이 있으면 경결을 풀어준다.

-> 1) SCM 부착부 및 SCM 촉진해서 통증부위는 심부건마사지

-> 2) SCM 부착부인 Mastoid 에서는 습부항 치료

-> 3) 습부항 치료 후 침치료 후 약침치료 시행

앞뒷판)

안면부 혈자리: 태양, 인당, 사죽공, 권료, 거료, 사백, 상관, 지창, 대영, 교근

후경부 혈자리: 풍지, 예풍, 풍부, 솔곡



5. 치료-침 치료

루틴 혈자리

태양, 사죽공, 거료, 권료, 하료, 지창, 협거, 하관

(오래되면 오래될수록 근육의 경결이 있으므로, 경결을 풀어줘야 한다)

(안면마비 오래되어 이미 접힌 근육은 당겨줄 필요가 있다-매선)

*안면마비의 치료포인트

•입술이 아래로 안내려가는 경우는 경광근이 안내려가서 그런경우가 많다. 목 근육도 같이 봐줄것

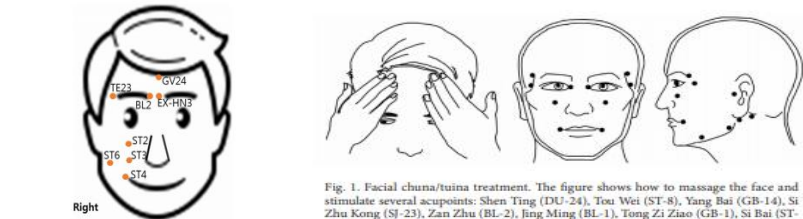


Fig. 2. Location of the acupuncture points in a patient with right-sided facial paralysis (for left-sided facial palsy, the left ST4, ST6, ST2, ST3, TE23, and BL2 were applied).

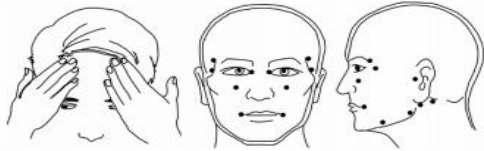


Fig. 1. Facial chuna/tuina treatment. The figure shows how to massage the face and stimulate several acupoints: Shen Ting (DU-24), Tou Wei (ST-8), Yang Bai (GB-14), Si Zhu Kong (SI-23), Zhan Zhu (BL-2), Jing Ming (BL-1), Tong Zi Ziao (GB-1), Si Bai (ST-2), Ting gong (SI-19), Yi Feng (SJ-17), Jia Che (ST-6), Da Ying (ST-5), Di Cang (ST-4). The black dot shows an acupoint which is used in facial nerve palsy treatment.

5. 치료-약침 치료

약침은 왜 필요할까?

- > 항염약침 : **염증제거, Wash out** 정도로 설명
- > 초기 염증기, 이후통 있는 경우 해당부위 부종, **통증완화 위해 활용 설명.**
- > 자하거 약침 : **후기 근영양, 위축 및 퇴행방지**
- > 마비 후기 (7-14 일 정도 경과 후) **영양물질 공급으로 설명**

약침은 어디에 놓을까?

- > 주로 초기 염증기에는 이후부위에 놓음
- > 후기에는 안면근 위주(교근 혹은 하관, 관료 등에 시행)
- > 안면근에 시행할때는 니들 게이지가 얇은 것으로 시행

5. 치료-한약

•실증(말초성안면마비, 람세이헌트) :

- 1) 이기거풍산 / 2) 견정산 / 3) 이기거풍합견정산 / 4) 청담순기탕 (동의보감)
- 5) 가미패독산(람세이헌트)

-> 증상이 말초, 통증위주면 이기거풍산 혹은 견정산 위주. 중추성에 조금이라도 가까운거 같거나 담음계열이면 청담순기탕

•허실협잡 : 보익거풍산(보중익기탕 합 이기거풍산 합 견정산)

•허증 : 가미삼오칠산(연부), 탁리소독음, 보중익기탕

5. 치료-추나(무저항가동기법)

- 경추 추나를 진행하기도 하고 관련 근육을 풀어주기도 한다.
- 환자가 혼자서도 할 수 있는 기법을 알려주는 것도 좋다.

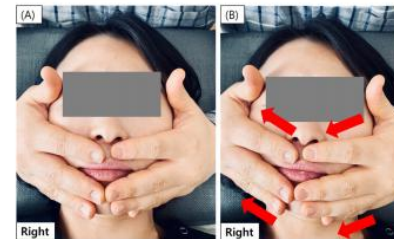


Fig. 1. The process of SJS-F for right-sided facial paralysis. (A) The starting position; (B) The operating position.



1. 중풍 후유증의 진료

- 아래는 모 커뮤니티에 올라온 학생의 고민 글(안 읽어도 됨)

한방병원에서 뭘 할 수 있나요?

이 논문을 읽으며 생각이 많아졌어요.

한방병원에서 진단한 내용은 죄다 오진이고, 진단을 맞게 하였더라도 우리가 하는 한방응급처치는 법적으로 전혀 보호받지 못하는 의미없는 행위네요.

의식이 불명할때 십선혈 사혈하라고 다들 배우셨죠?

구인환이 한방 항혈전제라는 것도 배우셨죠?

그런데 실전에서는 왜 제때 양방치료를 받게 하지 않고 저런 원시적인 방법만 썼냐고 책임을 추궁한다니.. 한방병원에서 수련하신 선생님들께 여쭙보고 싶습니다..

한방병원에서는 중풍, 뇌경색 환자를 본다 또는 그 후유증 환자를 관리한다고 홍보하는데..

대체 우리가 뭘 할 수 있는거죠?

중풍 후유증으로 반신마비가 된 환자를 침 치료 몇번 한다고 걸어서 퇴원시킬 수 있는건가요 정말? 그게 아니라면 한방병원은 그냥 요양병원처럼 청구수가나 보험수가를 타먹고 숙박업이나 하는 병원이란 얘기 아닌가요? 급 회의감이 들어서 생각이 많아지네요.

- 중풍이라고 중풍칠처혈만 활용하는 것은 옳지 않다. 만약 중풍이라고 계속 중풍칠처혈로만 치료를 하면 환자는 더이상 오지 않을 수 있다.(환자들은 다른 병원, 필라테스 등의 치료방법도 받아보기 때문에 한의원이 특별하게 해줄 수 있는 치료를 해줘야 한다)

- 교수님의 이런 경우에 환자의 손가락이나 등쪽을 풀어주는 치료를 함께 진행한다고 한다.(척추 치료 주 3회, 7-8개월)

- 솔직하게 말해서 중풍 환자가 드라마틱하게 치료되서 일상 생활로 돌아가는 것은 거의 없다. 또 골든타임이 생각보다 의미 없는게, 골든타임을 놓치고 내원하는 환자들이 대부분이다.(심평원에 따르면 발견된 후 6 시간만에 혈관내재개통치료를, 3 시간만에 혈전용해술을 시행하는 것이 좋다고 한다)

- 교수님의 생각은 골든타임보다는 예방하는 것이 더 중요하다는 것이다.

2. 뇌졸중 후유증 진료의 중요성

1. 뇌졸중의 유병인구가 증가하고 있다.

- 뇌졸중 : 허혈성 뇌졸중(뇌경색) + 출혈성 뇌졸중(뇌출혈)

- 과거 출혈성 뇌졸중이 위주였다면 현재는 허혈성 뇌졸중

- 우리나라는 고령화되고 있으며, 75 세 이상의 뇌졸중 유병률은 55-74 세 인구의 2 배에 달함.

- 뇌졸중 환자의 5 명 중 4 명은 60 세 이상임.

- 사망률은 감소하나 위험인자 보유자, 유병률 증가로 유병인구는 증가 추세

2. 뇌졸중의 특성과 국내 의료 현황 상 뇌졸중 후유증 환자가 여전히 많다.

- 골든타임(Onset 이후 3 시간 내) 병원에 내원하는 환자 비율은 10 명 중 4 명

- Wake up stroke 등 Unclear-onset Stroke 가 36.2%에 달함.

- 6 시간 이후 혈관내재개통치료(endovascular recanalization therapy, ERT) 혹은 3 시간 이후 정맥 내 혈전용해술(tPA) 등의 효과가 떨어진다는 연구가 존재함

3. 재활 난민: 뇌졸중 발생, 그 이후

- 초기 3 개월(아급성기)까지는 회복기 재활병원, 요양병원 등에서 치료 및 관리

- 6 개월 이후 만성기 이후에는 요양병원 등을 옮겨다님

- 낙상으로 인한 골절, 욕창, 출혈 등이 발생하기 쉬운 환경

(뇌졸중 발생 1 년 내 출혈 발생률은 8.9%, 골절 발생률은 4.7%)

4. 여전히 한의의료기관에는 많은 뇌졸중 후유증 환자가 내원하고 있다.

- 2011 년도부터 2019 년도까지 한의분야 입원 환자 수 및 요양급여비용총액 상위 30 개 질환 분석 결과

- 뇌졸중 관련 코드 (I69 뇌혈관질환의 후유증, I63 뇌경색증, I61 뇌내출혈, G81 편마비 등) 2010 년 약 26%, 2019 년 9.5% (단, 한의분야 연평균 요양급여비용총액 성장률이 10%로 2010 년과 2020 년 뇌졸중 관련 진료 총액은 거의 유사한 수준)

- 또한, 뇌졸중 유병인구의 증가에 따라 한의원에 내원하는 환자들 중 한번이라도 뇌졸중을 겪어본 환자의 수가 점점 증가할 것으로 추정

3. 일차의료기관에 방문하는 뇌졸중 환자의 유형

1. 만성기의 환자 혹은 중풍 예방을 원하는 환자

- 어깨도 아프고 여기저기 쑤시고 불편해요. 예전에 풍을 한번 앓아서 그런가 바람만 불면~ (네? 중풍이 있으셨다구요?)
- 우리 사촌 언니가 풍으로 쓰러진 거 보고 무서워서

2. 아급성기의 환자 혹은 Old stroke(무증상)

- 한달 전에 중풍으로 입원했었어요. 가벼운 증상이라 약만 먹으면서 관리하래요
- 최근에 검진 상 MRI 를 찍어보았더니 예전에 풍이 한번 지나갔다고 의사가 운이 좋다고 하던데요

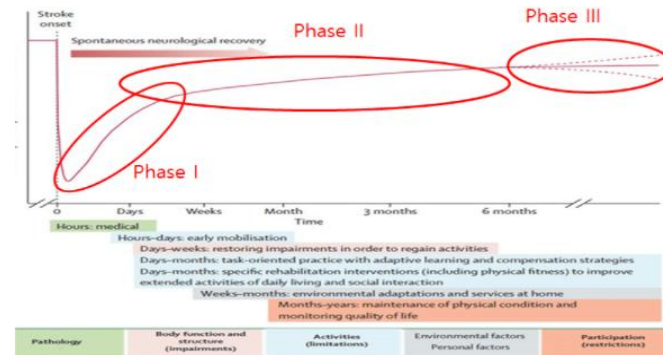
3. TIA(뇌허혈발작) 경험 환자

- 어제 갑자기 다리에 힘이 풀려 계단을 내려가다가 주저앉았어요.
- 어제 갑자기 팔에 힘이 한번 쭉 빠지더니 지금은 괜찮은데 먹먹한 느낌은 계속 남아있네요.

4. 초급성기의 환자

- 팔이 안올라가요, 아침부터 입이 틀어진 것 같아요.
- 머리가 깨질 것 처럼 아파요.

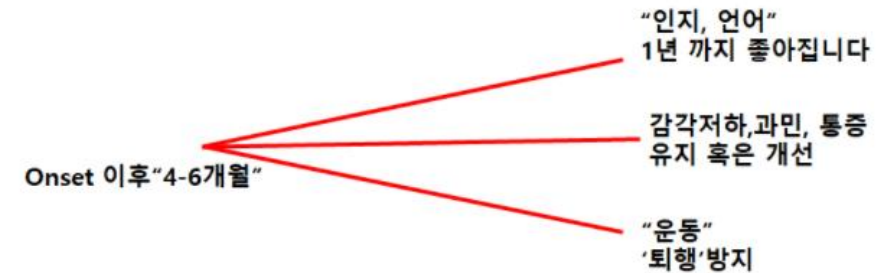
4. 뇌졸중 후유증 관리의 시작점



- 초급성기: 대략 7 일~2 주 / 급성기: 1 달~3 개월 / 아급성기: ~6 개월 / 만성기: 6 개월 이후

- 뇌의 가소성으로 뇌는 뇌졸중 발생 이후 회복을 시작함.

- 뇌졸중을 치료한다는 것은 가동 범위를 늘리고 자발적 기능회복을 촉진시키는 것이 가능한 시기인가를 고려하여 재발방지, 퇴행방지, 자세교정을 하는 것이다.



KOSCO 연구를 통해 뇌졸중 후 발병 6개월까지 의미 있는 기능 호전을 보이나, 이후 유지되는 경향을 보이는데 일상생활 동작 수행력(K-MBI), 보행(FAC), 언어기능(K-FAST)은 1년까지도 의미 있는 호전을 보임을 입증하였음.(Yoon JA, 2017 & Chang WH, 2016)

- 연구에 따라, 언어 기능 등은 특히 3 년 까지도 호전된 사례 등이 존재함.
- 6 개월 이후 환자가 치료의지 포기 등을 하지 않게 꾸준히 교육과 상담을 진행해야 함.

5. 뇌졸중 환자가 복용하는 약물

1. 재발 방지를 목적으로 한 약물

- 항혈소판제 혹은 항혈전제
- 항혈소판제: 주로 아스피린(아스트릭스), 플라빅스 뇌졸중 예방 효과는 낮은 편으로 보고됨. (내시경, 치과치료)
- 항응고제: 와파린, NOAC (자렐토, 엘리퀴스 등) 심방세동, 관상동맥 질환 환자에게 병용됨.
- 주로 아침 1 회 복용
- 수술, 치과진료, 내시경 전후 약물 중단 후 재개하기도 함. 약물 중단 후 재발 사례 2 건 있었으나

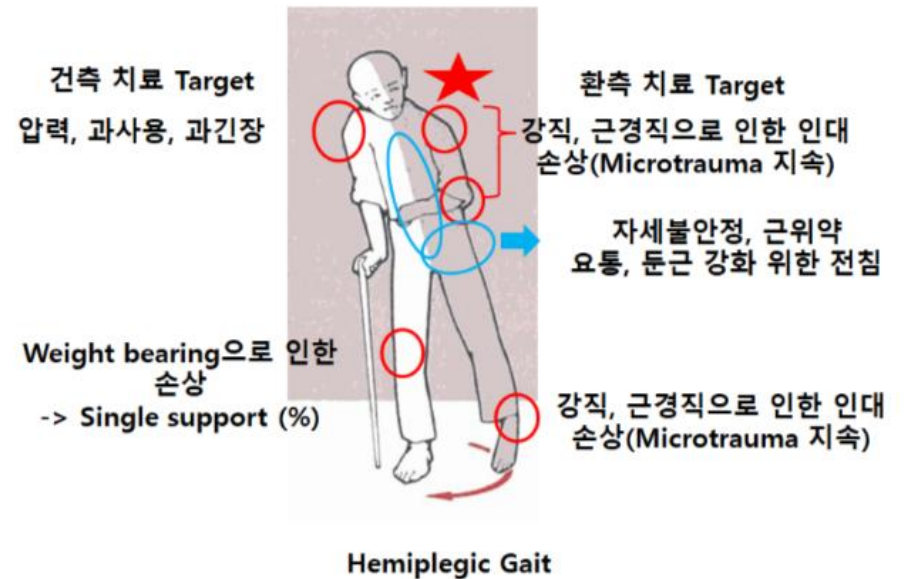
2. 위험인자 관리 약물

- 고지혈증: 실로스타졸, 클로피도그렐(아스피린을 병용하는 이중 항혈소판 요법(DAPT)), 리피토(아토르바스타틴)
- 고혈압
- 당뇨

여담

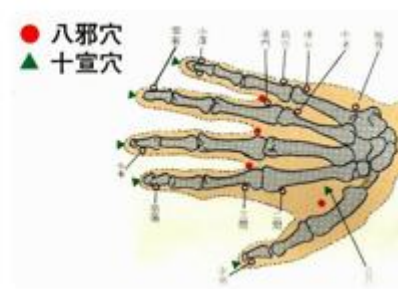
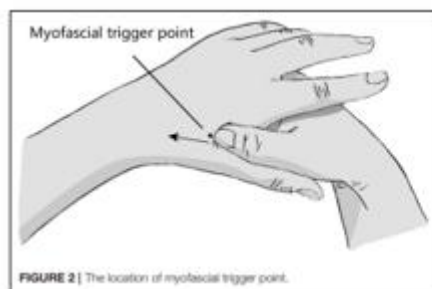
- 이명 환자 사례: 태음인 느낌의 아줌마로 경추와 턱관절이 많이 굳어 있어서 추나로 풀어주고 교근을 풀어주니 딱 소리가 나더니 이명이 사라졌다.

6. 뇌졸중 한의치료의 타겟 소개



- 위 그림은 보행, 자세 불균형으로 인해 발생하는 이차적 후유증에 대한 치료 타겟
- 내과적 치료 타겟으로는 뇌졸중 재발 방지, 기력약화, 뇌졸중 후 우울감, 피로개선, 근력 강화, 강직 및 구축 예방, 욕창 치료, 간수치 상승(다약제), 위장관 약화(운동부족), 섭생 지도 등이 있음

관련 논문



- 연구 결과에서 흥미로운 것은 연구진이 치료군에서 제시한 것처럼 “손가락이 꿈틀거릴 정도의 움직임 유발하거나, 방사통이 있을 정도의 강자극을 준 경우”에서 수지부 강직에 즉각적 효과가 있었고 trigger point 와 무관한 가 측 2mm 지점에 2mm 정도만 자입하는 경우에는 무처치군과 효과 차이가 크게 없었음을 확인했다는 것이다.



Immediate Effect of Dry Needling at Myofascial Trigger Point on Hand Spasticity in Chronic Post-stroke Patients: A Multicenter Randomized Controlled Trial

Zengqiao Zhang^{1,2}, Wu Wang³, Yongjie Song⁴, Tianjun Zhai⁵, Yan Zhu⁶, Liming Jiang⁷, Qunfeng Li⁸, Lei Jin⁹, Kunpeng Li¹⁰ and Wei Feng^{1,2*}

¹Department of Rehabilitation, South People's Hospital of Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai, China; ²School of Rehabilitation Science, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai, China; ³Department of Neurological Rehabilitation, Shanghai Second Rehabilitation Hospital, Shanghai, China; ⁴Department of Rehabilitation, Shanghai Haixing Hospital, Shanghai, China

OPEN ACCESS

Edited by:

Wen Guo Kim,

Soochow National University, South Korea

Reviewed by:

Peigang Wu,

National Research Center for

Rehabilitation Technical Arts, China

Specialty section:

Stroke,

Frontiers in Neurology

Received: 22 July 2021

Accepted: 05 September 2021

Published: 23 October 2021

Citation:

Zhang Z, Wang W, Song Y, Zhai T,

Zhu Y, Jin L, Li L, Li K and

Feng W (2021) Immediate Effect of

Dry Needling at Myofascial Trigger

Point on Hand Spasticity in Chronic

Post-stroke Patients: A Multicenter

Randomized Controlled Trial.

Front. Neuro. 12:745181.

doi: 10.3389/fnro.2021.745181

Background: Hand spasticity after stroke influences the rehabilitation of hand function. Immediate and effective relief of spasticity potentially creates conditions for later rehabilitation training, which has far-reaching significance in the smooth transition of patients to the recovery period.

Objective: To evaluate the immediate effect of dry needling (DN) at myofascial trigger point on hand spasticity in stroke patients.

Methods: This was a prospective, evaluator blind, multicenter, randomized controlled study. A total of 210 participants were randomly divided into DN group (DN, $N = 70$), sham dry needling group (SDN, $N = 70$), and control group ($N = 70$). Participants in the DN group were treated with DN at myofascial trigger point five times (30 min each time) every week for 4 weeks. Subjects in the SDN group were manipulated the same way as in the DN group, except that the acupuncture site was located in the area adjacent to the myofascial trigger point, which constituted a SDN. Routine rehabilitation treatment was performed for participants in the two groups and in the control group. The primary evaluation index was the immediate effect of hand spasticity relief. Secondary evaluation indicators included the cumulative effect of hand spasticity relief from baseline to week 4, and the changes in flexion angles of the wrist, thumb, and fingers 2–5 in the rest position before, immediately after, and 4 weeks after intervention.

Results: The immediate effective rate of spasticity relief (thumb, fingers 2–5, and wrist) of patients with different degrees of spasticity in the DN group was higher than that in the control and SDN groups (thumb, $\chi^2 = 55.833$, $P < 0.001$; fingers 2–5, $\chi^2 = 65.095$, $P < 0.001$; wrist, $\chi^2 = 49.180$, $P < 0.001$) ($P < 0.05$). The effective rate of spasticity relief from baseline to 4 weeks in the DN group exceeded that in the control group and SDN groups (thumb, $\chi^2 = 8.906$, $P = 0.012$; fingers 2–5, $\chi^2 = 8.087$, $P = 0.016$; and wrist, $\chi^2 = 8.653$, $P = 0.013$) ($P < 0.05$). No difference in immediate and cumulative effect was found between the control group and SDN group. The change of joints flexion angles in

7. 급성 뇌경색의 임상적 증후-TIA(교수님이 중요하게 언급)

- 일과성 허혈성 발작(TIA)는 15 분 혹은 그 이하의 유지시간을 가진다. (6 시간 이상 지속된 경우 14%)
- MRI 상에서 나타나지 않는 경우도 있음. (30~50%)
- 뇌경색 환자에게서 12~30%에서 발병 전 선행 경험 (특히 연구에 따라, ¼에서는 발병 수시간 전에 TIA 경험 했다는 보고도 있음)
- 교수님은 감별점으로 환자가 장바구니를 가지고 가다가 웬지모르게 놓치는 경우와 같이 증상이 나타나는 것을 보신다..

CMAJ

COMMENTARY

Preventing stroke after transient ischemic attack

Michael D. Hill MD MSc, Shelagh B. Coutts MD

See related research article by Perry and colleagues on page 1137 and at www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.101668.

THE NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

One-Year Risk of Stroke after Transient Ischemic Attack or Minor Stroke

Pierre Amarenco, M.D., Philippa C. Lavallée, M.D., Julien Labrecque, B.S.T., Gregory W. Albers, M.D., Natan M. Bornstein, M.D., Patricia Canhã, M.D., Louis R. Caplan, M.D., Geoffrey A. Donnan, M.D., José M. Ferro, M.D., Michael G. Hennerici, M.D., Carlos Molina, M.D., Peter M. Rothwell, M.D., Leila Sissani, B.S.T., David Školoudik, M.D., Ph.D., Philippe Gabriel Steg, M.D., Pierre-Jean Touboul, M.D., Shinichiro Uchiyama, M.D., Eric Vicaut, M.D., and Lawrence K.S. Wong, M.D., for the TIARegistry.org Investigators*

ABSTRACT

BACKGROUND

Previous studies conducted between 1997 and 2003 estimated that the risk of stroke or an acute coronary syndrome was 12 to 20% during the first 3 months after a transient ischemic attack (TIA) or minor stroke. The TIARegistry.org project was designed to describe the contemporary profile, etiologic factors, and outcomes in patients with a TIA or minor ischemic stroke who receive care in health systems that now offer urgent evaluation by stroke specialists.

8. 뇌졸중 후유증 관리 한의치료 증례 소개-어지러움증(그냥 소개)

- 대한한방내과학회지 제41권 6호(2020년 12월)
J. Kor. Korean Med. 2020; 41(6): 1185-1188
<http://dx.doi.org/10.2224/kjkm.jkm.2020.41.6.1185>

대한한방내과학회지 제41권 6호(2020년 12월)
J. Kor. Korean Med. 2020; 41(6): 1222-1226
<http://dx.doi.org/10.2224/kjkm.jkm.2020.41.6.1222>

성황정기산가미방을 중심으로 한 한의약 치료법을 통해
단기간에 호전을 보인 전순환계 신경성 후 발생한
지남력장애 및 현훈을 주치료 한 환자 1례에 대한 보고

외상성 뇌손상 후 불안장애 양상이 발생한 환자 1례에 대하여
연계감조장을 무기한 증례보고

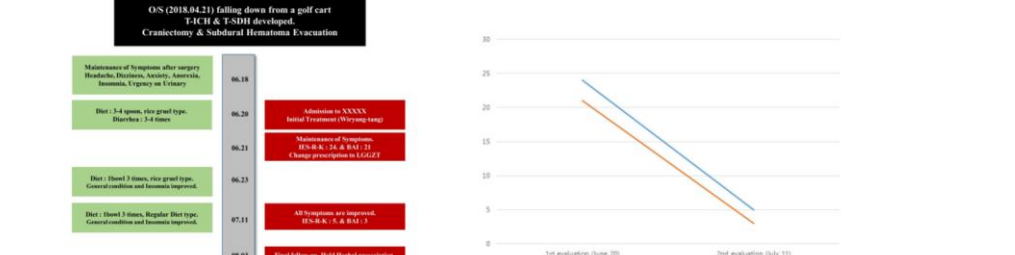
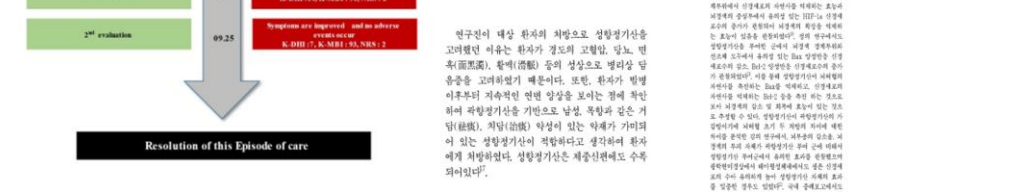
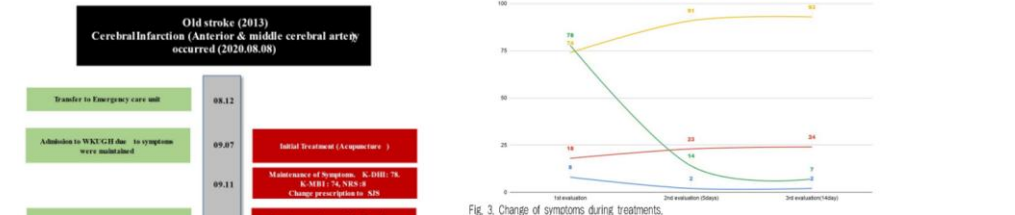
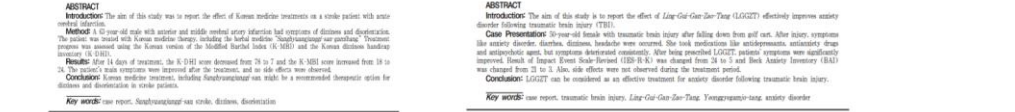
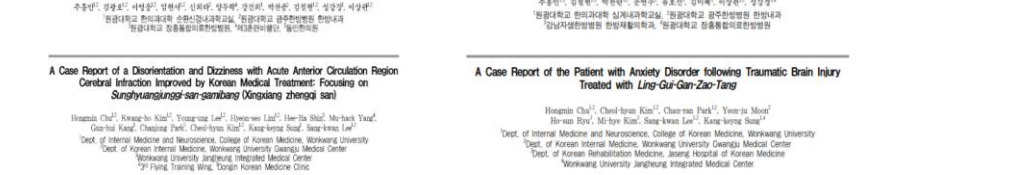


Fig. 2. Timeline of patient's treatment

8. 뇌졸중 후유증 관리 한의치료 증례 소개-고령환자, 빈혈(그냥 소개)



Fig. 3. Change of fecal state of the patient.

(A) melanorrhagia observed the following day morning (B) hematochezia recurrent the same day afternoon (C) after taking Taklisodok-eum 1 weeks, normalized feces observed.

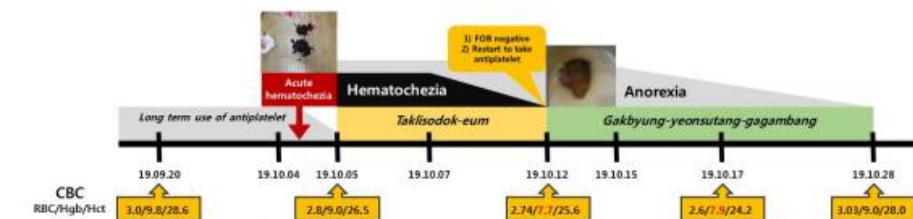


Fig. 4. Timeline of patient's history and follow-up results.

FOB : fecal occult blood test

흑색변의 감별진단

- 보통 선혈을 보이며, 대변에 섞여 있거나, 타르와 같은 검은색을 띠기도 한다. 곧창자에서 선혈이 있는 경우를 혈변이라고 하는데, 잘룩창자암이나 게실질환, 또는 궤양성 대장염에서 보일 수 있다. 대변에 피가 섞이는 경우도 궤양성 대장염, 게실질환, 암, 또는 치질일 때 보일 수 있다.

- ★흑색변

: 검은색이고, 타르와 같은 변은 샘창자의 첫 번째 부위보다 위쪽에서 출혈이 있는 경우 혈액소의 부분적인 소화에 의해 생긴다. 어지러움, 오심, 발한의 경우 심한 **위장관출혈**, 저혈압을 의심한다. 흑색변의 원인은 다음과 같다.

- 1) 식도 질환 : 식도암, 식도염, 식도 열상, 식도정맥류 파열
- 2) 위 질환 : 위궤양, 위염, 위암
- 3) 소장 질환 : 궤양, 염증성 장질환, 소장암
- 4) 약물 및 음식 : 시금치 혹은 선지 등 철분 함유 음식, 철분제제 복용, 변비
철분제제, 비스무스(bismuth) 제제, 감초

Part5. 기타 혈액검사 소개 및 앞으로의 혈액검사(수업 안했는데 시험 나올까봐 넣음)

출혈 경향 검사: PT, aPTT, INR

1) PT : 프로트롬빈시간

- 혈액내 프로트롬빈의 전체량을 나타내는 검사법.
- 정상은 약 12 초.
- 프로트롬빈 농도가 25% 이하로 떨어지면 PT 시간 연장됨.
- 외인성 경로 평가

2) aPTT : 활성부분트롬보플라스틴시간

- 내인성 경로 평가

3) INR : PT 측정 반응속도나 민감도가 많이 달라지기에 시약마다 고유의 PT 비율을 활용하여 보정하여 보고하는 방식. INR 정상 PT 시간 2-3

Risk of Antiplatelet Therapy (김0운/M/77)



Cb-inf(Lt.LSA territory) patient.

Fx : Pneumoconiosis, Ventricular tachycardia

After simple Falls(slip down), Patient complained bruise, pain, heating sense and night pain.

Risk of stopping antithrombotic agent – Rebound effect



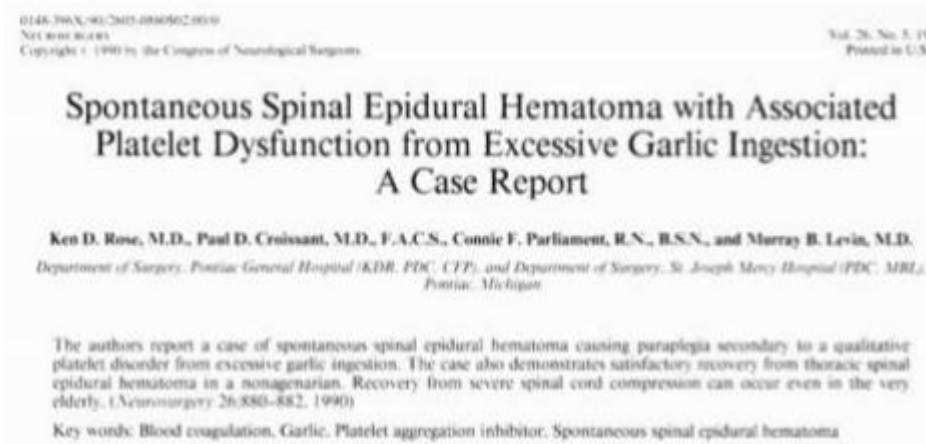
유0순 (F/78) Cb-inf(Rt.MCA territory) patient.

1st stroke(당시 거의 무증상)으로 항혈전제 지속 복용했다고 함.

L spine stenosis로 OP 시행 위해 항혈전제 복용 중단. OP 시행 후 복용 재개.

Lt side weakness developed 되어 MRI상 Cb-inf 진단.

- 소규모 임상연구에 의하면 하루 4 쪽 정도의 마늘양은 출혈 위험을 증가시키지 않음.
- 다만, 항혈소판제를 복용하는 환자에게서 4 쪽 분량의 마늘 진액을 Inj 혈종 발생한 사례 보고.



Overview of the Interaction between Warfarin and Korean Herbal Medicine

¹Dept. of Korean Medicine, School of Korean Medicine, Pu-San National University
²Dept. of Internal Medicine, College of Oriental Medicine, Won-Kwang University
³Dept. of Korean Medical Science, School of Korean Medicine, Pu-San National University
⁴Dept. of Internal Medicine, Korean Medicine Hospital of Pu-San National University

- JKMST

ISSN: 2713-6590
<https://doi.org/10.5448/JKMS2021.5.1.96>
 Journal of Korean Medical Society of Soft Tissue 2021;5(1):96-10

김철현^{1,2,*}, 김광호^{1,2}, 이영웅^{1,2}, 강선이^{1,3}

¹원광대학교 광주한방병원 한방내과, ²원광대학교 한의과대학 순환신경내과학교실

Cheol-hyun Kim^{1,2,*}, Kwangho Kim^{1,2}, Young-ung Lee^{1,2}, Sunny Kang^{1,2}

¹Department of Korean Internal Medicine, Wonkwang University Gwangju Medical Center, Gwangju, ²Department of Internal Medicine and Neurosciences, College of Korea Medicine, Wonkwang University, Gwangju, Korea

Received September 6, 2021
Revised September 7, 2021
Accepted September 10, 2021

Received September 6, 2021
 Revised September 7, 2021
 Accepted September 30, 2021

Corresponding Author
 Dr. J. H. Kim, MD, PhD
 Department of Korean Internal Medicine,
 Seoul National University College of Medicine,
 Clinical Research Center, 151-047, Seoul,
 Korea. 134-023, Hwangjeong, Incheon,
 Korea. 61276, Korea.
 Tel.: +82-02-6310-6412
 Fax: +82-02-6487-6482
 E-mail: yoon2002@snu.ac.kr

Introduction: This study aimed to report that INR level of a patient with cardioembolic stroke taking warfarin was adjusted through herbal medicine administration without adjusting the dose of warfarin.

Case Presentation: This was a case of 64-year-old male patient diagnosed with cardioembolic stroke. The patient's INR level fluctuated greatly during her hospital stay, so we requested her university hospital to adjust the warfarin dose, but they only said that this was because of the her diet. After we administered the herbal medicine, we controlled the INR level by ourselves through herbal medicine administration.

Conclusion: For patients taking warfarin with fluctuating INR levels, the most economical and effective way to control the warfarin dose is to administer the herbal medicine. If possible, it is thought that a positive effect can be achieved through the combination of herbal medicines.

Keywords: Case report, Cardioembolic stroke, Warfarin, INR, Insaembakcheung

*Corresponding Author

Chod Hyun Kim
Department of Korean Internal Medicine,
Wonkwang University Gwangju Medical
Center, 1340-23, Hyeonje-n, Nam-gu,
Gwangju 61729, Korea
Tel: +82-62-670-6412
Fax: +82-62-670-6492
E-mail: user2307@hwanmail.net

Keywords: Case report, Cardioembolic stroke, Warfarin, INR, Insambaeckhab-tan

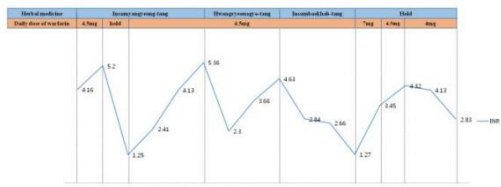


Figure 2. Timeline of The Case: The type of herbal medicine or the dose of warfarin was changed after checking the INR value for the day.

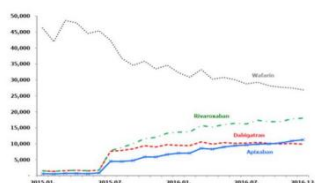


그림 19. [참용교재] 사용량 추이(2015-2016)

혈전 위험의 판단: D-Dimer

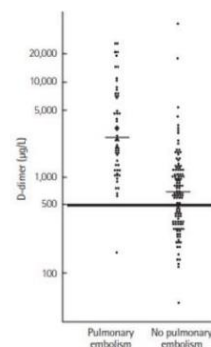


Fig. 1. D-dimer concentrations measured in plasma from patients with and without PE. The horizontal bold line represents the cutoff value. Reproduced from Bounameaux et al. [11] with the permission of the publisher.

1) TAKE-HOME MESSAGES

D-dimer는 정맥혈전색전증의 배제나 확진을 위하여 단독으로 사용해서는 안 된다. 증상이 있는 환자에서 예비임상자료들과 민감한 방법의 D-dimer 검사를 동시에 시행할 때 정맥혈전색전증 **배제**하는 데 **안전하게** 사용할 수 있다. 그러나 다음의 환자에서는 혈전증이 있을 때에도 위음성으로 나올 수 있으므로 D-dimer를 안전하게 사용하지 못할 수도 있다(Table 4). (a) 정맥혈전색전증 증상이 나타난 지 14일 이상인 환자(오래된 혈전은 플라스민에 의한 분해가 감소하므로 D-dimer가 위음성으로 나타날 수 있다). (b) 저섬유소용해를 가지는 환자. (c) 정맥혈전색전증 의심 하에 치료되었지만 임상적으로 혈전증은 사용하는 환자(이러한 약제는 D-dimer 생성을 억제한다). 마지막으로, 예비임상자료들과 조합한 D-dimer 검사는 노인, 입원환자 또는 개발한 정맥혈전색전증 환자에서는 주의해서 사용해야 한다(Table 4). 위의 상태에서는 낮은 특이도에 예상해야 하고, D-dimer를 사용하더라도 낮은 특이도 때문에 관련된 비특이한 음성결과를 시행해야 한다.

혈액점도검사

1. 의학의 발전에 대한 피신입니다.

2. 점의 3.5에 대하여

- 한방에서 환자의 진단 치료 및 학술연구를 목적으로 소변 제취 검사 등을 바거나, 피를 뽑는 제법 행하는 가능하다 할 것이나, 양 방 의학적 이론에 의한 검사를 목적으로 할 수는 없을 것으로 사료됨.

3. 점의 2에 대하여

- 한방에서 현미경으로 혈구나 혈액의 구조 등을 알람 의학적 이론에 의하여 검사하는 것은 인위적 피트행위를 일으키는 것이나 한방이 가 한방의학적 이론에 근거하여 혈액의 점도, 이혈(血液) 상태, 살피 진찰·치료·연구 목적으로 현미경 등의 기구로 활용하였나면 이는 한방 의료의 영역에 속한다고 할 수 있을 것임.

4. 점의 3에 대하여

- 위 사항을 벗어난 행위는 의료법 제25조제1항의(무면허의 의료 행위 등 금지) 에 해당함.

▲ 보건부 1999년 11월 12일 유권해석

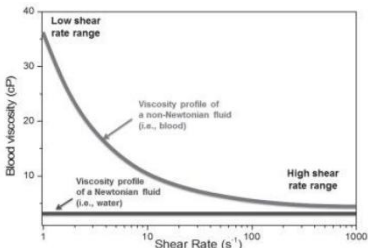


그림 3. 전단율 변화에 따른 물의 점도 변화(파란선) 및 혈액의 점도 변화(빨간선) 그래프[3, 4]

전단율 (s ⁻¹)	혈액 점도 정상 범위[5]		
	전체	남성	여성
1	18.36~35.68	23.15~36.45	18.20~27.36
50	4.32~6.79	4.96~6.97	4.22~5.60
100	3.87~5.96	4.29~6.16	3.77~4.97

1999년 보건복지부 유권해석

혈액의 점도를 살펴보는 것은 가능.

2022년 한의학혁신기술개발사업 성과교류회

2형 당뇨병 환자에 대해 심적완이 혈액점도에 미치는 효과와 안전성 연구: 체계적 문헌고찰과 메타분석

최현정*, 김광현*, 김광현* (1:1, equal contribution)
한양대학교 2. 최주식 보건소 정동환전신소 (*, co-correspondence)

연구의 필요성
2형 당뇨병 환자는 심적완이 혈액점도에 미치는 효과와 안전성을 평가하기 위해 체계적 문헌고찰과 메타분석을 수행하였다.

연구 방법
PubMed, EMBASE, Cochrane 등 데이터베이스를 검색하여 2형 당뇨병 환자에 대해 심적완이 혈액점도에 미치는 효과와 안전성을 평가하는 체계적 문헌고찰과 메타분석을 수행하였다.

연구 결과
심적완이 혈액점도에 미치는 효과는 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않았다. 또한, 심적완이 혈액점도에 미치는 효과는 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않았다.

결론
심적완이 혈액점도에 미치는 효과는 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않았다. 또한, 심적완이 혈액점도에 미치는 효과는 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않았다.

혈액검사를 활용한 신의료기술이 지속 등재 시도(그렇구나 하고 넘어가자)

※ 2016.5월 이후 신청 건만 대상으로 작성

적혈구 내 6-TGN, 6-MMP 검사
[크로마토그래피-질량분석법]

07

신청횟수 5회(재신청)

접수번호(접수일) 2013-224 (2013.10.31.) 2014-051 (2014.4.10.) 2014-153 (2014.8.6.) 2014-228 (2014.11.4.) 2017-093 (2017.7.24.)

보고서 번호 미발간 미발간 미발간 미발간 HTA-2018-27

신의료기술 등재에 실패해도 지속 재신청 중인 다양한 혈액검사 기반 기술들

알츠하이머병 혈액 진단기술 진일보 신호탄?

알츠하이머 혈액 진단기술의 수반으로서 혈액검사의 예측정확도를 높일 수 있는 방법에 관한 연구 결과가 발표됐다.

알츠하이머 혈액 진단기술의 수반으로서 혈액검사의 예측정확도를 높일 수 있는 방법에 관한 연구 결과가 발표됐다.

대장암, 혈액으로 진단

한국기초과학지원연구원

혈액으로 대장암 진단 기술 개발

앞으로 혈액검사를 통해 암, 치매 등에 대한 진단도 가능해질 것이고, 현재보다 더 간편하고 빠르게 진단할 수 있는 혈액검사기도 개발될 것입니다. 지금부터 활용과, 해석을 해야 한다고 생각합니다.